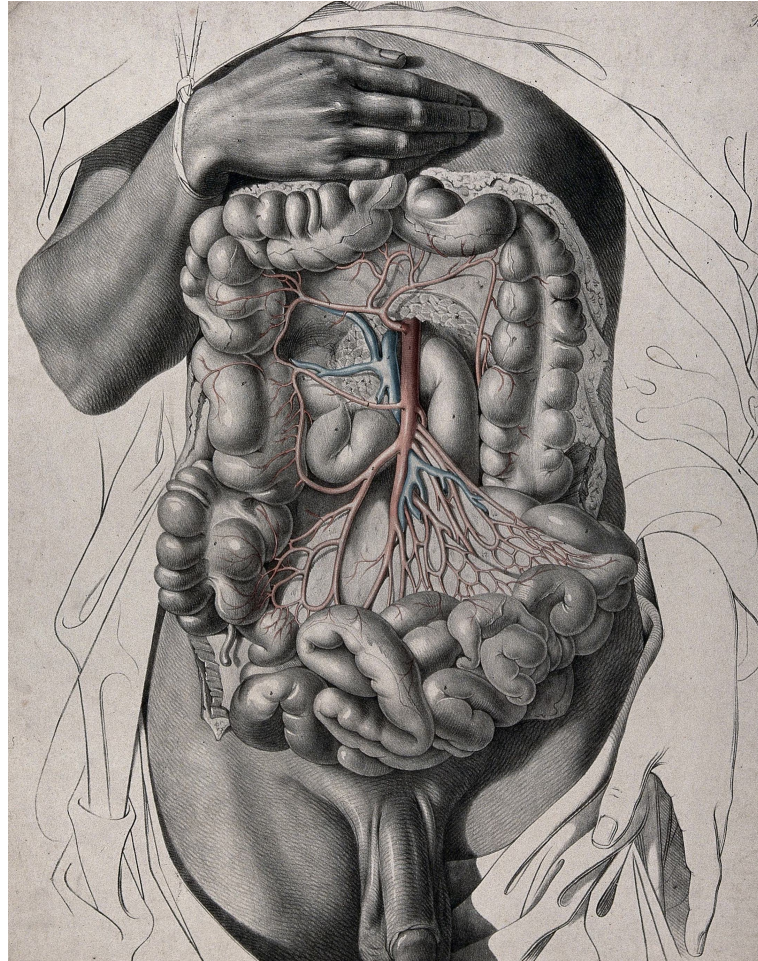
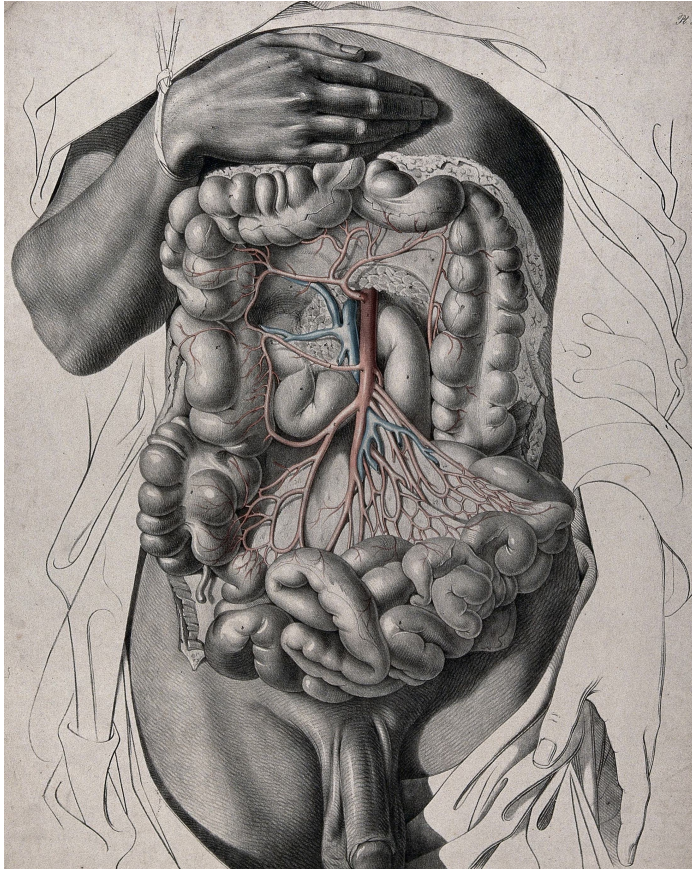


Gastro-entérologie et hépatologie : Pathologies fréquentes



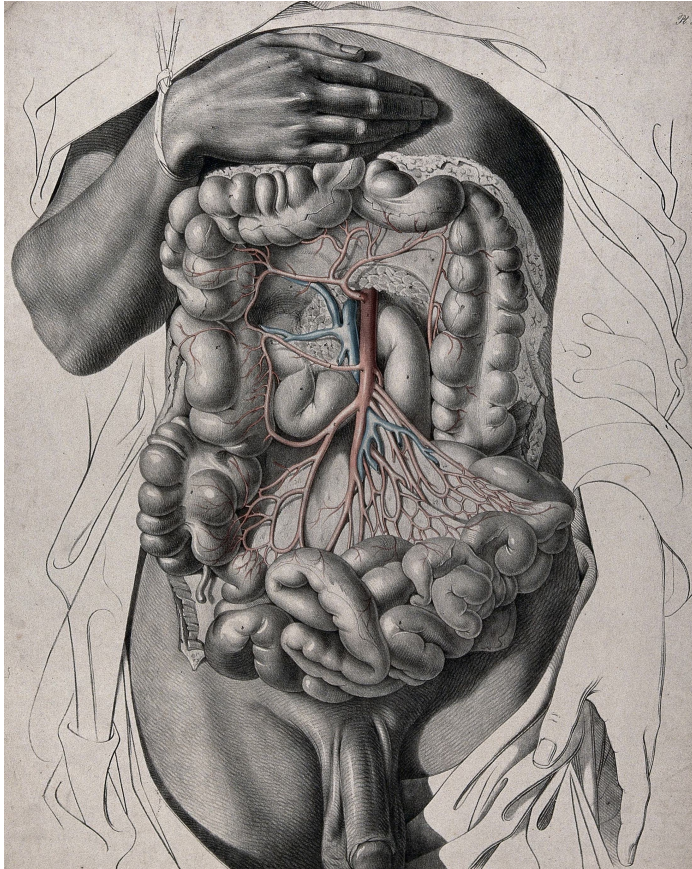


Colique biliaire simple

- **Cliniques:** Douleurs **choliques** dans l'**hypochondre droit** ± irradiation vers l'épaule droite ou le dos. Fréquemment accompagné de **nausées et de vomissement**. Typiquement **postprandial**, en particulier après un repas riche en lipide. Chercher les facteurs risques classiques : **Fat, Female, Forty, Fertile**. FR rare : Trouble de la résorption des **sels biliaires** (atteinte iléale, ie sur **M.Crohn**) => Lithiase **cholestérolique**. FR rare : **Excès de bilirubine** sur **hémolyse** (ie: anémie auto-immune, thalassémie) => Lithiase **Bilirubine**.
- **Note:** 70% lithiase **cholestérolique**, 5% **bilirubine** => **Radio-transparent** (Invisible à la Rx ASP), 25% lithiase **d'oxalate calcium** => **Radio-opaque** (visible sur une simple Rx ASP)
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP, Leucocytes** et **VS** pour exclure une **cholécystite/cholangite**, **Lipase** pour exclure **pancréatite** (cave : calcul dans le sphincter de Oddi), Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour exclure **cholestase** (si cholédocholithiase), **ASAT/ALAT** pour exclure des dégâts hépatiques (**hépatite cholestatique**) **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans la vésicule biliaire), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (largeur >7cm) si **cholédocholithiase**, Normalement, absence d'épaississement de la paroi et de signe de Murphy échographique (signe de cholécystite)
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS, Paracétamol, Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**) Jeûne pour les prochaines 24h et RAD, **cholécystectomie élective** à discuter En présence d'un calcul dans le cholédoque (**cholédocholithiase**) -> **ERCP** en urgence

Cholécystite

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec en plus un **signe de Murphy positif** et un **EF** (syndrome inflammatoire sur infection de la vésicule biliaire provoqué par une cholestase)
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP, Leucocytes** et **VS** pour confirmer l'infection et le syndrome inflammatoire, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite** (cave : calcul dans le sphincter de Oddi) Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour **exclure cholestase**, **ASAT/ALAT** pour exclure des dégâts hépatiques (**hépatite cholestatique**) **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans la vésicules), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'un **hydrops vésiculaire** (longueur >10cm) et un **épaississement de la paroi** (> 3mm).
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS, Paracétamol, Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), Traitement de l'infection (*germes fréquents: E.coli, E. faecalis*) avec combinaison **C3G**(FQ/co-amox) + **Metronidazole** Si possible **cholécystectomie dans les 24h** (moins de complication que si effectuée dans les semaines qui suivent)

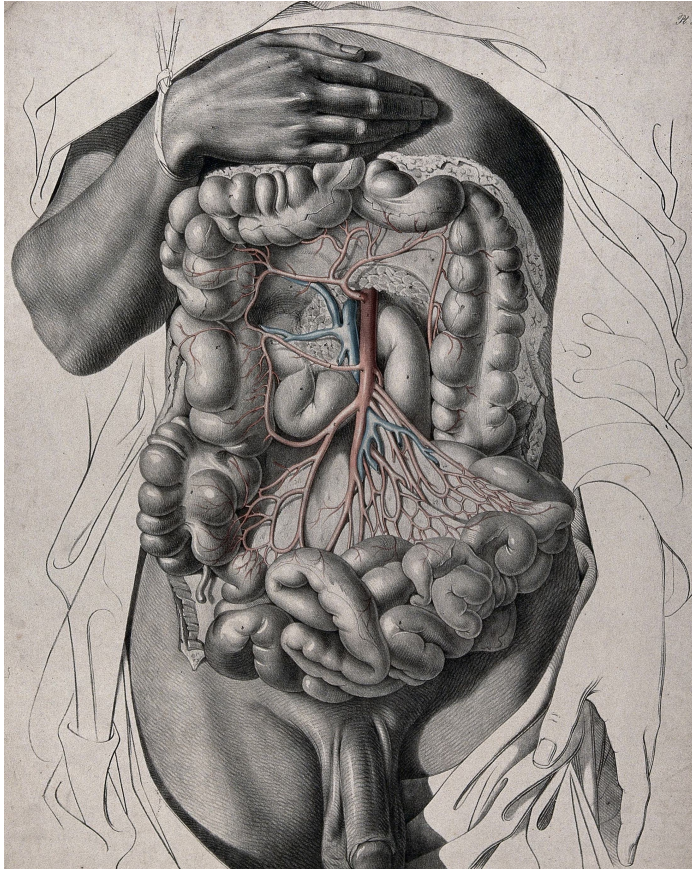


Cholédoquolithiase

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec éventuellement en plus un ictère
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP**, **Leucocytes** et **VS** pour exclure une **cholécystite/cholangite**, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite**, Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour confirmer la **cholestase**, **ASAT/ALAT** pour confirmer l'atteinte **hépatiques** (légèrement augmenté dans le cadre d'une hépatite cholestatique), **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans le cholédoque), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (diamètre >7mm) et d'un **élargissement des voies biliaires intra-hépatique**,
- **Traitement :** Gestion de la douleur (**AINS**, **Paracétamol**, **Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), **ERCP** en urgence (diagnostic et thérapeutique, avec papillotomie et extraction de la lithiase), puis **cholécystectomie** dans les 72h

Cholangite

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec en plus un ictère et un EF Chercher la **triade de Charcot** : Ictère + EF + Douleurs hypochondre droit
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP**, **Leucocytes** et **VS** pour confirmer la cholangite, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite**, Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour confirmer la **cholestase**, **ASAT/ALAT** pour confirmer l'atteinte **hépatiques** (légèrement augmenté dans le cadre d'une hépatite cholestatique), **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans le cholédoque), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (diamètre >7mm) et d'un **élargissement des voies biliaires intra-hépatique**,
- **Traitement :** Gestion de la douleur (**AINS**, **Paracétamol**, **Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), Traitement de l'infection (*germes fréquents: E.coli, S. faecalis*) avec combinaison **C3G**(FQ/co-amox) + **Metronidazole**, Si début de cholangiosepsis : élargir le spectre avec **piperacillin-tazobactam** ou **Carbapem** **ERCP** en urgence (diagnostic et thérapeutique, avec papillotomie et extraction de la lithiase), puis **cholécystectomie** dans les 72h

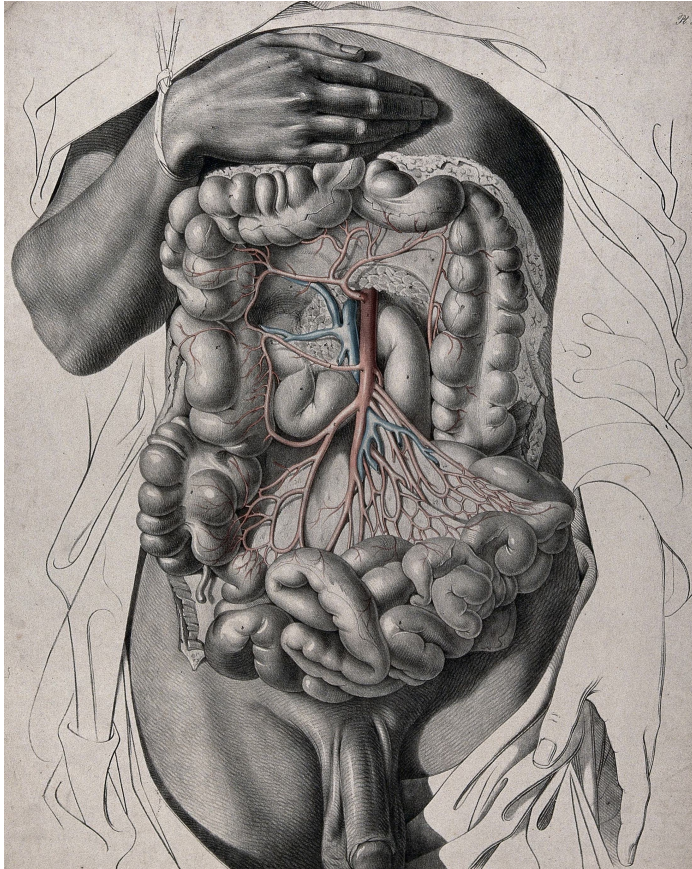


Pancréatite aigüe

- **Cliniques:** Épigastralgie **transfixiante** avec irradiation vers le dos, **en ceinture**.
Possiblement surajouté à des douleurs de type cholique (en cas de pancréatite sur lithiasie biliaire).
Souvent accompagné de nausée et de vomissement, d'un sub-iléus paralytique et d'un météorisme.
Des **ecchymoses** sont parfois visibles à des localisations particulières : péri-ombilical, sur les flancs ou au niveau inguinal
- **Notes:** Causes principales sont la **lithiasies** compliquée (40%) et l'**abus d'alcool** (35%).
Les autres causes sont médicamenteuse, virales, sur variation anatomiques...
- **Diagnostic:** Douleurs typiques + élévation des **lipases sérique** (3x normes) + imagerie typique (US ou plus tard CT) => 2/3
Labo avec **Leucocyte**, **pro-calcitonine**, **CRP** et **VS** (inflammation, infection), **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** (cholestase),
Chercher des **défaillances d'organes** : PaCO₂/PaO₂ et fréquence respiratoire, créatinine, TA et fréquence cardiaque
Doser le **calcium** (hypercalcémie => toxique pour pancréas) et **TG** (hypertriglycidémie comme cause de pancréatite),
Imagerie : Dans un premier temps **US** (chercher un œdème, une lithiasie),
Éventuellement ajouter investigation à l'**ECRP** et/ou **IRM** si doute sur lithiasie ou obstruction par une tumeur.
Seulement après 3-5 jours, **CT-scan injecté** (score de Balthazar) : œdème, nécrose, abcès
- **Traitement** : Si **pancréatite légère** (majorité des cas) -> gestion de la **douleur**, **monitoring** en soins continus (TA, O₂, urine...),
prophylaxie des thrombose (**heparine**), prophylaxie d'un ulcère de stress avec **IPP**,
Si surinfection (abcès, sepsis), traitement agressif : combinaison **C3G/FQ** + **Metronidazole**, durée de traitement de 10 jours
Traitement de la cause si possible (en particulier **ERCP** puis cholécystectomie si cause lithiasique).
Quelques jours après hospitalisation, CT-scan et **traitement endoscopique/percutané** si nécessaire :
Si kyste pancréatique ne se résolvant pas spontanément, abcès ou nécrose : Drainage, débridement
Pas oublier de nourrir le patient dès que possible (rester à jeun est non conseillé) !

Pancréatite chronique

- **Cliniques:** Épigastralgie **transfixiante** irradiant en ceinture et vers le dos, **chronique**. S'accompagne des signes d'une perte progressive des fonctions exocrines (**syndrome de malabsorption**, **stéatorrhée**) et ultimement endocrine (**diabète**).
Note: Les causes principales sont l'**alcoolisme** chronique (80% des cas), **idiopathique** (15%) et finalement sur différentes causes se chevauchant parfois (tabac, hyperparathyroïdisme, pancréatite auto-immune, pancréatite familiale...)
- **Diagnostic:** Anamnèse et FR typique, **lipase sérique** élevée, **elastase fécale** abaissée.
Imagerie : US ou CT mettant en évidence des calcifications et une fibrose du tissu, parfois des pseudo-kystes.
- **Traitement** : Arrêt des toxiques (**tabac**, **OH**), **hormone pancréatique** lors des repas ± complémentation en vitamine liposoluble **ADEK** par voie parentérale si carence, traitement **insulinique** en cas de diabète.
Si fibrose et sténose du canal de Wirsung, intervention endoscopique avec dilatation au ballon ou **stent** pour permettre bien vider les sucs pancréatiques dans le duodénum. **Draînage** des abcès et des kystes. Traitement de la douleur selon OMS.

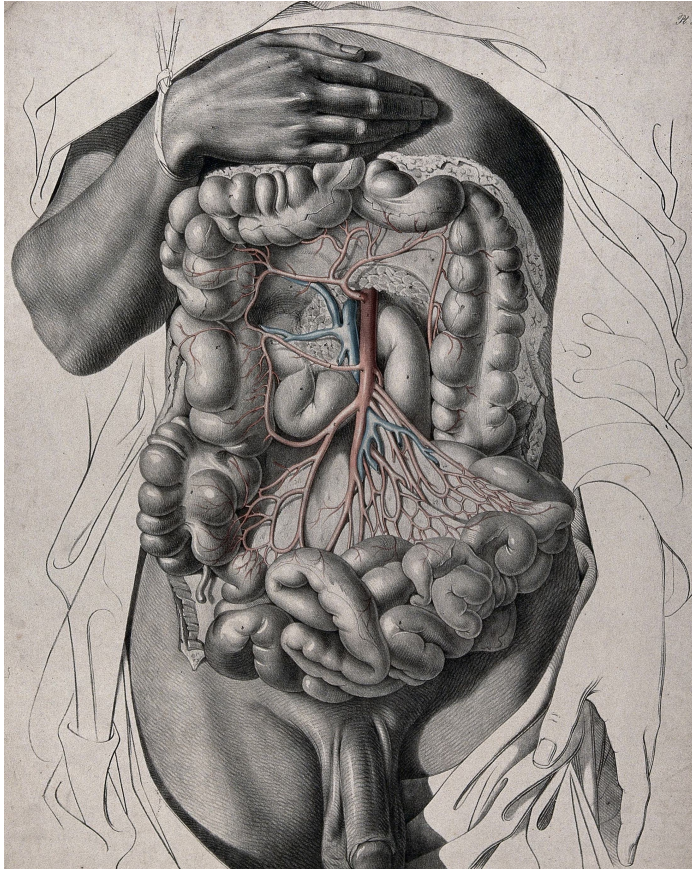


Hépatite aigüe (virale)

- **Cliniques:** (1) Phase prodromale [7 jours] : État **grippal** avec **fièvre** et **fatigue**, **douleurs abdominal** en hypochondre droit. Dans l'hépatite aigüe à HBV, possibilité d'avoir un exanthème et des arthralgies (complexe immun entre HBs-Ag/Ac) Volontiers des signes neurologiques dans l'hépatite à **HEV** (**paralysie faciale**, **SGB**, amyotrophie)
(2) Hépatite [2-8 semaines] : Ictère et selles décolorées accompagné de prurit (cholestase intra-hépatique), hépatomégalie. En général, évolution favorable, rarement hépatite fulminante* (insuffisance hépatique aigüe).
*HAV < 1% / HBV ≈ 1% / HCV < 1% / HDV+HBV ≈ 3% / HEV ≈ 3% (*mais monte à 20% si femme enceinte*)
Notes: 95% sont causées par HAV, HBV et HDV, HCV, HEV. Les 5% restants sont causé par le CMV, EBV et des virus inconnues.
- **Diagnostic:** Sérologie virale (chercher les **IgM** pour tous les virus sauf HCV où on cherche en plus le **HCV-RNA** sérique). Chercher les marqueurs de la fonction hépatique: Albumine, Quick/PT, Cholinestérase. Chercher des marqueurs de gravités: AP et GGT, ASAT et ALAT.
- **Traitement** : La plupart du temps, **repos** et évitement strict de tout toxique hépatique (**OH**, **médicament**). Traitement **antiviral anti-HBV** seulement si fonction hépatique réduite (entécavir/ténofovir ou IFN-a), Traitement **antiviral anti-HCV** d'office (sofosbuvir et velpatasvir). Traitement préventif (vaccination) pour **HAV** et **HBV/HDV**

Cirrhose

- **Cliniques:** Fatigues, douleurs en hypochondre droit, angiome stellaire et érythème palmaire, gynécomastie et perte de la pillosité pubienne chez les hommes / aménorrhée chez les femmes, ascite et diathèse hémorragique, atrophie cutané, Caput Medusae, hypersplénisme, ictère et prurit, coma et encéphalopathie hépatique.
Note: Les causes principales sont l'**alcoolisme** chronique (50% des cas) et les **hépatites virales** (40%). Plus rarement : NASH, l'hémochromatose (fer) ou le syndrome de Wilson (cuivre), les PBC/PSC ou le syndrome de Budd-Chiari (thrombose des veines hépatiques) => ≈5%
- **Diagnostic:** Chercher des signes **d'insuffisance hépato-cellulaire** : Hypoalbuminémie, diminution de la cholinestérase, rallongement du Quick/PT, augmentation de la bilirubine non-conjuguée. **Signe d'hypertension portale** avec une thrombopénie. **US** pour confirmer le diagnostic et faire le suivi, **élastométrie** pour mesurer le degré de fibrose.
- **Traitement** : Arrêt des toxiques (**médicament**, **OH**), traitement de la maladie sous-jacente et prise en charge des complications (varices, ascite et péritonite bactérienne spontanée, encéphalopathie, diathèse hémorragique...)

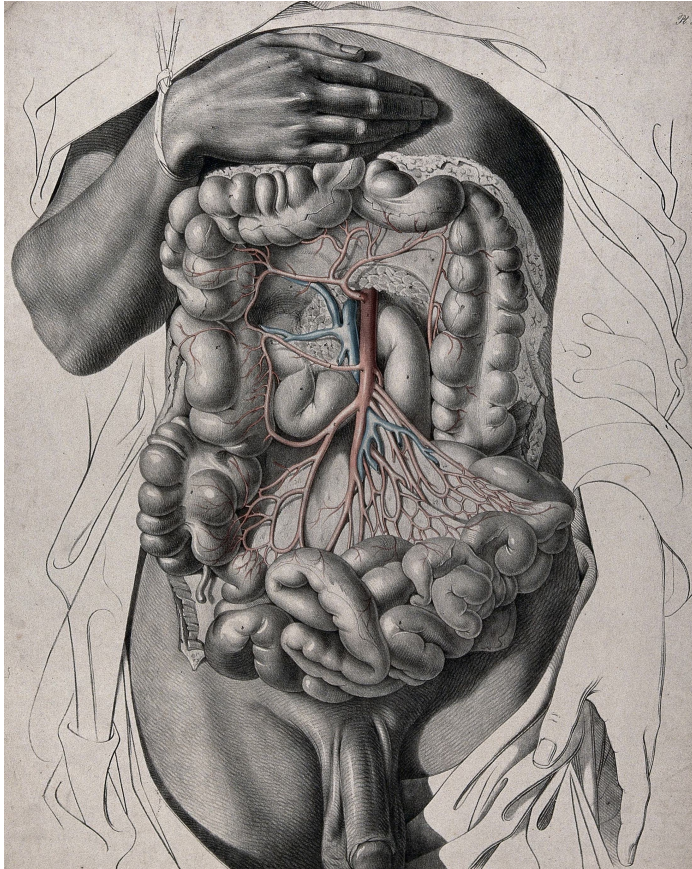


Appendicite

- **Cliniques**: Douleurs croissantes, d'abord difficilement localisables puis migrant en **fosse iliaque droite**. Éventuellement état fébrile voir péritonisme en cas de complication.
- **Diagnostic**: Cliniquement, chercher un **signe du psoas** et une douleur à la palpation du point de **McBurney**. Loges rénales non douloureuses, signe de Murphy négatif.
Laboratoire : paramètre inflammatoire (VS, CRP, Leucocytes). Stix urinaire pour exclure une cause urinaire.
US (chercher le signe de la cocarde), si non concluant IRM ou CT scan. Rx en cas de suspicion de perforation (Rx thorax)
Si EF et frissons : prélever des hémocultures.
- **Traitement** : **Appendicectomie** par laparoscopie ou traitement antibiotique (**Co-Amoxicilline + Metronidazole**).
En cas de perforation, toujours appendicectomie !

Diverticulite

- **Cliniques**: Inflammation d'un diverticule, au niveau du sigmoïde (colon distal) ou au niveau du caecum (colon proximal). Clinique similaire à une appendicite avec migration en **FIG** (ou **FID**, plus rarement). En plus, présence de sang dans les selles. Attention : La clinique peut-être silencieuse dans la population immunosupprimée.
Note: La diverticulose touche >50% de la population âgée de >70 ans.
Risque d'inflammation et de diverticulite d'environ 5% par année.
90% des diverticulites concerne le colon gauche, plus rarement le caecum (plus fréquent chez les japonais).
- **Diagnostic**: CT-scan (ou US) nécessaire pour poser formellement le diagnostic, et pour guider la suite de PEC
- **Traitement** : De manière générale, nourriture parentérale et hydratation iv.
Type 1: En cas de diverticulite simple (**sans abcès**, **sans perforation**), traitement conservatif à **domicile**
Type 2a et 2b : Si présence **d'abcès** : hospitalisation et AB (**C3G+Metronidazole**) ± **drainage** de l'abcès
Type 2c : En cas de **perforation** (ou absence d'amélioration avec tt conservateur), indication pour une **sigmoïdectomie**.
Type 3: En cas de récurrence, possible d'organiser une opération électorale.



MICI : Maladie de Crohn et Colite ulcéreuse

- **Cliniques:** De manière générale, **douleurs abdominales chroniques** avec red-flag : **Sang** dans les selles et anémie, douleurs **insomniantes**, perte de poids et **syndrome carentiel**, présence de symptôme **extra-intestinaux** (pyoderma gangrenosum, uvéite, arthrite...), **fistule** périnéale et **aphtes**, histoire familiale.
Crohn: Érythème noueux, pyoderma gangrenosum, aphte, fistule et abcès périnéaux, spondylarthrite (**HLA-B27**), uvéite
Colite ulcéreuse : Idem Crohn avec moins d'atteinte périnéales mais risque de **cholangite sclérosante primitive**
- **Diagnostic:** **Calprotectine fécale** comme porte d'entrée, si élevée aller à l'**endoscopie ± biopsie**.
- **Traitement :** Arrêt tabac (Crohn), **médicament immunosuppresseur**.

Colite microscopique

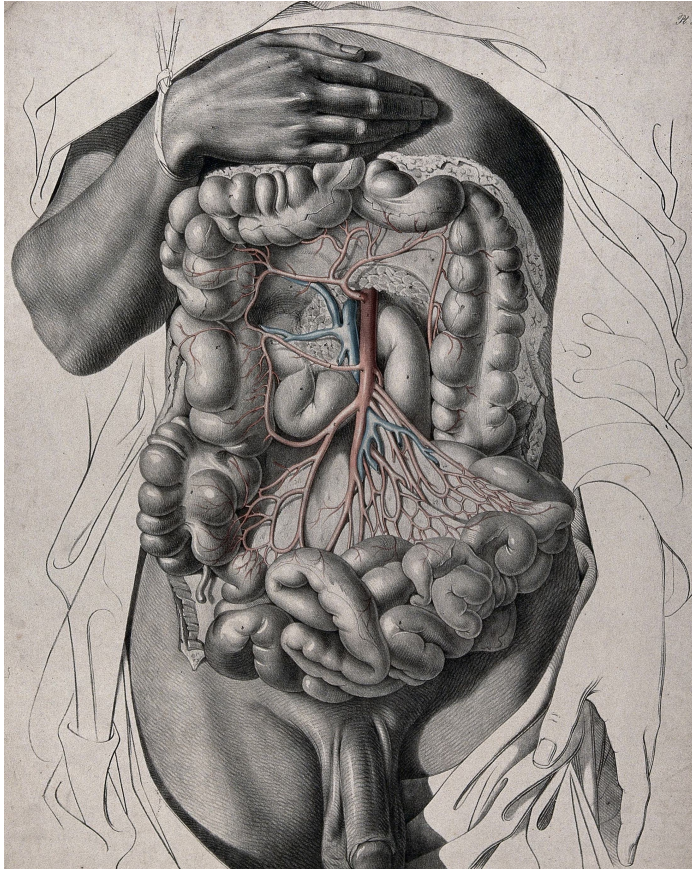
- **Cliniques:** Diarrhée aqueuses chroniques.
- **Diagnostic:** Le seul moyen de poser le diagnostic est d'effectuer une endoscopie avec **biopsies étagées** du colon.
- **Traitement :** Arrêt tabac, **médicament immunosuppresseur**.

Coeliaquie :

- **Cliniques:** Forme 'classique' avec diarrhée, **malabsorption**, trouble croissance staturo-pondérale et atteinte hépatique. Forme sans malabsorption également possible, de même que des formes avec atteintes à la biopsie et la présence d'Ac mais sans symptômes. Symptômes extra-digestifs : **dermatite herpétiforme**.
- **Diagnostic:** **Ac-anti-TG** de type **IgA** (rarement IgG), **HLA-DQ2** et **DQ-8**. Confirmation avec **endoscopie et Bx**.
- **Traitement :** Arrêt du **gluten**.

Intestin irritable :

- **Cliniques:** Douleurs abdominales souvent mal caractérisées, parfois avec altération du transit (diarrhée, constipation ou les deux). Bien chercher et exclure tous **red-flag** justifiant une endoscopie ou un scanner : Début après **50 ans**, accompagné de **fièvre** et d'un **amaigrissement**, douleurs nocturnes **insomniantes**, sang des selles ou **anémies**, prise récente **d'antibiotiques**, ANTCD de **MICI** ou de **CCR**.
- **Diagnostic:** Recherche de parasites dans les selles et dosages de la calprotectin fécale avec labo simple (notamment CRP, VS, Leuco et Hb). Si le bilan revient dans la norme, réassurer et éviter des interventions inutiles supplémentaires (CT-scanner, colonoscopie, gastroscopie...)

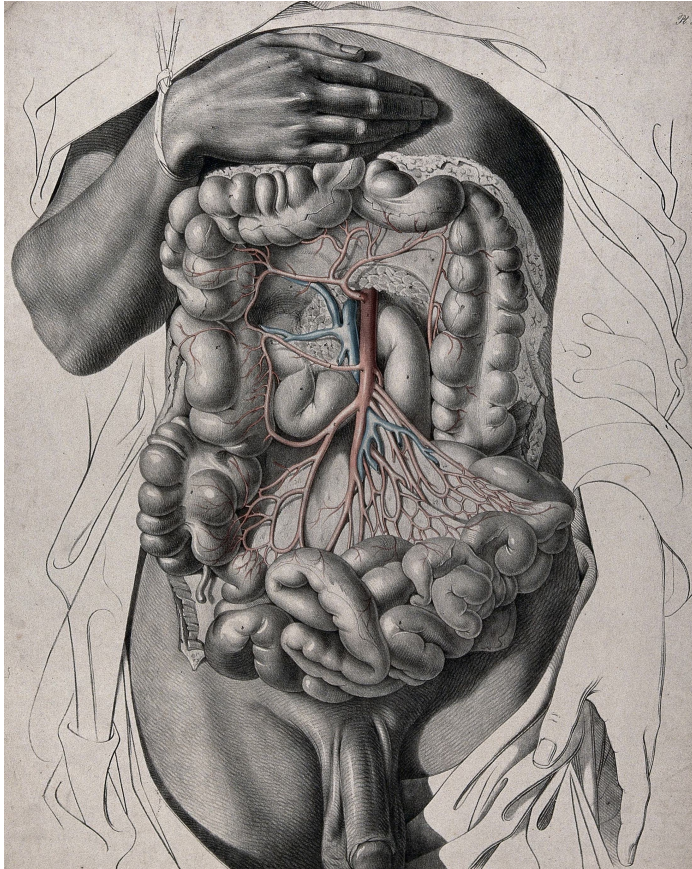


Gastrite et ulcère :

- Cliniques:** Épigastrie, nausée et vomissement, sensation de pression/trop plein. En cas d'ulcère présence de sang dans les selles (**mélène**). En cas de perforation, épigastrie aiguë avec **péritonisme**.
Diagnostic: Radio de thorax à la recherche d'air libre si suspicion de perforation, Chercher des facteurs risques (**tabac**, **OH**, **AINS ± Cortisol**, biphosphonate, stress).
 Prise de sang à la recherche d'une **anémie** et recherche de **sang occultes** dans les selles.
 Éventuellement dosage gastrine et la PTH.
 Sérologie ou test fécale pour **H. pylori**.
 En cas de doute et pour confirmer le diagnostic, **gastroscopie** et **Bx**.
Note : Causes rares : Hyperparathyroïdisme, gastrinome (maladie de Zollinger-Ellison : Diarrhée, ulcère, reflux)
Traitement : Traitement de fond par **IPP**, éliminer les **toxiques** (tabac, OH, AINS), chercher et éradiquer **H. pylori** (combinaison IPP + Clarithromycine + Amoxicilline/Metronidazole).
 En cas de saignement aiguë : **endoscopie** en urgence, **chirurgie** en cas de perforation et péritonite.

RGO et oesophagite à eosinophile :

- Cliniques:** Douleur rétrosternale, épigastrie, **pyrosis**, en particulier post-prandial (**signe du lacet**), **toux et laryngite**
- Diagnostic:** Diagnostic le plus souvent clinique, confirmé par un traitement d'épreuve par IPP.
 pH-métrie possible en cas doute.
 En cas de facteurs de risques pour un Barrett (homme, >50 ans, ANTCD familiaux, RGO longue date) : **Gastroscopie et Bx**
- Traitement :** Surveiller par des **endoscopies** avec **Bx**, traiter les **FR modifiables** (repas, surélever tête lit, surpoids...),
 Traitement de fond par **IPP**
- Remarque :** En cas de non réponse au traitement pas IPP, en particulier si symptômes d'obstruction (impaction) et terrain atopique (dermatite atopique, asthme...), penser à un **oesophagite à eosinophile**. Diagnostic par endoscopie avec Bx,
 Traitement avec **stéroïdes locaux** et **éviction de l'allergène** en cause (si possible).



Ischémie mésentérique :

- Cliniques**: Touche principalement les **femmes âgées** (sex ratio 1:4, en moyenne >75 ans). Consulte pour une douleur abdominale soudaine avec un **ventre souple paradoxal**. Souvent des diarrhées **sanglantes** accompagnent les douleurs.

Tri-phasique : Douleurs durant plusieurs heures (4h), puis intervalle non-douloureux (6h) jusqu'au choc septique et à la péritonite (décompensation aigüe). Clinique très **aspécifique**, souvent sans signe d'appel clair dans la phase initiale (abdomen souple). De plus, une progression lente des symptômes en cas de problèmes veineux (thrombose) plutôt qu'artérielle.
- Diagnostique**: Chercher des FR pour augmenter la suspicion :

Thrombose artérielle : Dysplasie fibro-musculaire, artérite, rupture d'anévrisme mésentérique (tabav + HTA)

Embolie artérielle : Trouble du rythme comme une **FA**, **valvulopathie** (valve mécanique), **arrêt d'un tt anticoagulant**

Thrombose veineuse : hypertension portale (stase), **thrombophilie** (cancer, APLS, grossesse/COC, mutation facteur V...)

Petit débit non obstructif : **Choc** (toute causes), déshydrations, drogue vasoconstrictrice (cocaïne...)

Labo : Leucocytose et D-Lactate (très sensible, aspécifique). Le **CT-injecté** est sensible à >90%.
- Traitement** : Si péritonisme, **laparoscopie exploratrice immédiate**. Autrement, **stent** ou **thrombolyse**.

Hospitalisation obligatoire, souvent en SI, car association fréquente avec un choc et un MODS.